DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: JUAN CARLOS VILLAFAÑE OROZCO **Identificación** CC 94391749
Edad: 50 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS SA SUBSIDIADO 2025
Sala: QUIROFANO 2 **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
2	030227	EXPLORACION Y DESCOMPRESION HASTA DOS SEGMENTOS POR FORAMINO TOMIA VIA PERCUTANEA	Y47	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía: COLUMNA LUMBAR				
2	030301	EXPLORACION Y DESCOMPRESION DE RAIZ DEL NERVIO ESPINAL	Y47	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
4	036103	LISIS O RESECCION DE ADHERENCIAS EXTRADURALES EN MEDULA ESPI NAL O RAICES DE NERVIOS ESPINALES VIA PERCUTANEA	Y47	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
4	038201	NEUROLISIS DE RAICES ESPINALES	Y47	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
1	053202	NEUROLISIS DE PLEJO LUMBAR	Y47	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
1	053204	NEUROLISIS DE PLEJO TORACICO	Y47	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
2	383505	RESECCION DE MALFORMACIONES VASCULARES EN VASOS ESPINALES	Y48	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
2	385402	CIERRE, PINZAMIENTO O LIGADURA DE VASOS ESPINALES	Y41	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
2	778967	VERTEBRECTOMIA PARCIAL LUMBAR VIA POSTERIOR	Y46	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
2	793950	REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA DE COLUMNA VERTEBRAL (TORACICA , LUMBAR O SACRA) VIA ANTERIOR	Y41	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
2	793952	REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA DE COLUMNA VERTEBRAL (TORACICA , LUMBAR O SACRA) VIA POSTERIOR O POSTEROLATERAL	Y41	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
2	805129	ESCISION DE DISCO INTERVERTEBRAL EN SEGMENTO LUMBAR VIA POST ERIOR PERCUTANEA	Y42	
Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO		**Especialidad:** NEUROCIRUGIA		
Vía:				
2	819002	VERTEBROPLASTIA CON COLOCACION DE DISPOSITIVO INTRACORPORAL	Y42	

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

Cirujano: JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO **Especialidad:** NEUROCIRUGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES219 JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO **Especialidad** NEUROCIRUGIA

030227	**EXPLORACION Y DESCOMPRESION HASTA DOS SEGMENTOS POR FORAMINO TOMIA VIA PERCUTANEA**
030301	**EXPLORACION Y DESCOMPRESION DE RAIZ DEL NERVIO ESPINAL**
036103	**LISIS O RESECCION DE ADHERENCIAS EXTRADURALES EN MEDULA ESPI NAL O RAICES DE NERVIOS ESPINALES VIA PERCUTANEA**
038201	**NEUROLISIS DE RAICES ESPINALES**
053202	**NEUROLISIS DE PLEJO LUMBAR**
053204	**NEUROLISIS DE PLEJO TORACICO**
383505	**RESECCION DE MALFORMACIONES VASCULARES EN VASOS ESPINALES**
385402	**CIERRE, PINZAMIENTO O LIGADURA DE VASOS ESPINALES**
778967	**VERTEBRECTOMIA PARCIAL LUMBAR VIA POSTERIOR**
793950	**REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA DE COLUMNA VERTEBRAL (TORACICA , LUMBAR O SACRA) VIA ANTERIOR**
793952	**REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA DE COLUMNA VERTEBRAL (TORACICA , LUMBAR O SACRA) VIA POSTERIOR O POSTEROLATERAL**
805129	**ESCISION DE DISCO INTERVERTEBRAL EN SEGMENTO LUMBAR VIA POST ERIOR PERCUTANEA**
819002	**VERTEBROPLASTIA CON COLOCACION DE DISPOSITIVO INTRACORPORAL**

Dx Preoperatorio: S320 FRACTURA DE VERTEBRA LUMBAR

Dx Postoperatorio: S320 FRACTURA DE VERTEBRA LUMBAR

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** PROGRAMADA
Cantidad de Sangrado: 10 **ml.** **Vía:** DIFERENTE VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
Hora Inicio 11:20:00 **Hora Final** 12:15:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:

LISTA DE SEGURIDAD, PROFILAXIS ATB CON VANCOMICINA, AZTREONAM, CLINDAMICINA.
BAJO ANESTESIA GENERAL, PACIENTE DECUBITO PRONO, REALCE PELVICO Y TORACICO.
CONFIRMACION DE AREA DE INTERES QUIRURGICO CON EVIDENCIA DE FRACTURA DEL PLATILLO SUPERIOR DE L2 POR LO QUE SE DECIDE REALIZAR CEMENTACION Y ARTRODESIS INTRACORPORES A ESTE CUERPO VERTEBRAL.
ASEPSIA, ANTISEPSIA CON CLORHEXIDINA.
COLOCACION DE CAMPOS ESTERILES E IOBAN.
VIA TORACICA:
BAJO GUIA FLUOROSCOPICA SE IDENTIFICAN LAS ARTICULACIONES FACETARIAS DE T11-12 Y LOS RAMOS POSTEROMEDIALES
CORRESPONDIENTES.
SE REALIZA NEUROLISIS DE RAÍCES POSTEROMEDIALES DE T11-12 CON SUSTANCIA QUIMICA.
SE REPOSICIONA AGUJA Y SE REALIZA NEUROLISIS CON SUSTANCIA QUIMICA DE PLEJO TORACICO BILATERAL
SE PALPAN ADHERENCIAS EXTRADURALES, REALIZÁNDOSE LISIS DE LAS MISMAS CON DEXAMETASONA Y BUPIVACAÍNA.
SE OBSERVAN VASOS ESPINAESL LUMBARES CON SANGRADO ACTIVO, REALIZÁNDOSE OCLUSIÓN Y CIERRE DE LOS MISMOS.
VIA LUMBAR:
BAJO GUIA FLUOROSCOPICA SE IDENTIFICA LA PROYECCIÓN CUTÁNEA DEL PEDÍCULO DE L1.
SE IDENTIFICA LA ARTICULACIÓN FACETARIA SE REALIZA RIZOLISIS Y NEUROLISIS DEL RAMO POSTEROMEDIAL DE LAS FACETAS LUMBARES DE L1 CON BUPIVACAÍNA MÁS DEXAMETASONA.
SE REPOSICIONAN AGUJAS BAJO GUIA FLUOROSCOPICA Y REALIZO NEUROLISIS CON SUSTANCIA QUIMICA A PLEJO LUMBAR BILATERAL.
SE IDENTIFICAN ADHERENCIAS EXTRADURALES INTERFACETARIAS Y SE REALIZA LISIS Y RESECCIÓN DE ADHERENCIAS EXTRADURALES DE L1-2.
SE IDENTIFICAN LAS RAÍCES DE L2-3 Y SE REALIZA NEUROLISIS DE LAS MISMAS CON BUPIVACAÍNA MÁS DEXAMETASONA.
SE OBSERVA SANGRADO ESPINAL PROVENIENTE DE DISTINTOS VASOS ESPINALES DORSALES Y SE REALIZA OCLUSIÓN Y PINZAMIENTO DE VASOS ESPINALES A ESTE NIVEL.
SE REALIZA TOMA PEDICULAR BILATERAL DE L1 CON CANULAS DEL SUSTEMA CONFIDENCE.
SE PALPA HUESO TRABECULAR REBLANDECIDO Y SE REALIZA VERTEBRECTOMIA LUMBAR CON CÁNULA.
SE REALIZA NUEVAMENTE TOMA PEDICULAR DE L1 Y SE REALIZA DESCOMPRESIÓN DE LA RAÍZ DE L1 A TRAVÉS DE

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

PEDICULECTOMÍA PARCIAL CON LO CUAL SE LIBERAN LAS RAÍCES.
SE OBSERVAN FLUROSCÓPICAMENTE FRAGMENTOS DE FRACTURA CON COMPRESIÓN DEL CANAL RAQUÍDEO Y SE REALIZA VERTEBRECTOMÍA ADICIONAL, ADEMÁS DE DESCOMPRESIÓN DEL CANAL RAQUÍDEO.

SE AVANZA LA CÁNULA HACIA EL DISCO INTERVERTEBRAL DE T12-L1 Y SE REALIZA DISCOIDECTOMÍA (ESCISIÓN DEL DISCO).
SE REPOSICIONA CÁNULA HACIA LA REGIÓN MEDIAL DEL CUERPO VERTEBRAL ENCONTRANDO SANGRADO TRABECULAR. SE APRECIAN MALFORMACIONES VASCULARES ESPINALES SECUNDARIAS AL TRAUMA Y SE REALIZA RESECCIÓN DE DICHAS MALFORMACIONES VASCULARES, CON LO CUAL SE LOGRA HEMOSTASIA.
SE POSICIONA CÁNULA VERTEBRAL.
SE REALIZA REDUCCIÓN DE LA FRACTURA VERTEBRAL POR CEMENTACION - VERTEBROPLASTIA CON CEMENTO CONFIDENCA.
SE REACOMODA LA CÁNULA HACIA LA REGION LATERAL Y SE REALIZA DESCOMPRESIÓN DEL TRONCO TORÁCICO DESCOMPRIMIENDO SU ASPECTO MÁS LATERAL CERCA A LOS NEUROFORAMENES ESPINALES.
SE REPOSICIONA CÁNULA HACIA EL ENDPLATE SUPERIOR DE LA VÉRTEBRA Y SE REALIZA ARTRODESIS INSTRUMENTADA DE LA REGION DORSAL CON CEMENTO ÓSEO.
SE REPOSICIONA CÁNULA HACIA LA REGIÓN MEDIAL SE REALIZA VERTEBROPLASTIA INYECTANDO CEMENTO OSEO EN LA REGIÓN MEDIA DE LA VÉRTEBRA.
BAJO GUIA FLUOROSCOPICA SE IDENTIFICA LA PROYECCIÓN CUTÁNEA DEL PEDÍCULO IZQUIERDO DE L2.
SE IDENTIFICA LA ARTICULACIÓN FACETARIA SE REALIZA RIZOLISIS Y NEUROLISIS DEL RAMO POSTEROMEDIAL DE LAS FACETAS LUMBARES DE L2 Y L3 CON BUPIVACAÍNA MÁS DEXAMETASONA.
SE IDENTIFICAN ADHERENCIAS EXTRADURALES INTERFACETARIAS Y SE REALIZA LISIS Y RESECCIÓN DE ADHERENCIAS EXTRADURALES DE L2L3
SE IDENTIFICAN LAS RAÍCES DE L3 Y DE L4 Y SE REALIZA NEUROLISIS DE LAS MISMAS CON BUPIVACAÍNA MÁS DEXAMETASONA.
SE OBSERVA SANGRADO ESPINAL PROVENIENTE DE DISTINTOS VASOS ESPINALES DORSALES Y SE REALIZA OCLUSIÓN Y PINZAMIENTO DE VASOS ESPINALES A ESTE NIVEL.
SE REALIZA TOMA PEDICULAR BILATERAL DE L1 CON CANULAS DEL SUSTEMA CONFIDENCE.
SE PALPA HUESO TRABECULAR REBLANDECIDO Y SE REALIZA VERTEBRECTOMIA LUMBAR CON CÁNULA.
SE REALIZA NUEVAMENTE TOMA PEDICULAR DE L2 Y SE REALIZA DESCOMPRESIÓN DE LA RAÍZ DE L2 A TRAVÉS DE PEDICULECTOMÍA PARCIAL CON LO CUAL SE LIBERAN LAS RAÍCES.
SE OBSERVAN FLUROSCÓPICAMENTE FRAGMENTOS DE FRACTURA CON COMPRESIÓN DEL CANAL RAQUÍDEO Y SE REALIZA VERTEBRECTOMÍA ADICIONAL, ADEMÁS DE DESCOMPRESIÓN DEL CANAL RAQUÍDEO.
SE REPOSICIONA CÁNULA HACIA LA REGIÓN MEDIAL DEL CUERPO VERTEBRAL ENCONTRANDO SANGRADO TRABECULAR. SE APRECIAN MALFORMACIONES VASCULARES ESPINALES SECUNDARIAS AL TRAUMA Y SE REALIZA RESECCIÓN DE DICHAS MALFORMACIONES VASCULARES, CON LO CUAL SE LOGRA HEMOSTASIA.
SE POSICIONA CÁNULA VERTEBRAL.
SE REALIZA REDUCCIÓN DE LA FRACTURA VERTEBRAL POR CEMENTACION - VERTEBROPLASTIA CON CEMENTO CONFIDENCE.
SE REACOMODA LA CÁNULA HACIA LA REGION LATERAL Y SE REALIZA DESCOMPRESIÓN DEL TRONCO TORÁCICO DESCOMPRIMIENDO SU ASPECTO MÁS LATERAL CERCA A LOS NEUROFORAMENES ESPINALES.
SE REPOSICIONA CÁNULA HACIA EL ENDPLATE SUPERIOR DE LA VÉRTEBRA Y SE REALIZA ARTRODESIS INSTRUMENTADA DE LA REGION DORSAL CON CEMENTO ÓSEO.
SE REPOSICIONA CÁNULA HACIA LA REGIÓN MEDIAL SE REALIZA VERTEBROPLASTIA INYECTANDO CEMENTO OSEO EN LA REGIÓN MEDIA DE LA VÉRTEBRA.
SE REALIZA CIERRE DE LAS HERIDAS.
SE REALIZA CURACIÓN DE LAS HERIDAS DE MANERA ESTÉRIL.
PACIENTE SE TRASLADA A SALA DE RECUPERACION ANESTESICA.
PROCEDIMEINTO REALIZADO BAJO VISION CONTINUA FLUOROSCOPICA

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

VIA 1:
RAÍCES ESPINALES, ADHERENCIAS EXTRADURALES, VASO ESPINAL SANGRANTE.
VIA 2:
FRACTURA DEL CUERPO VERTEBRAL L1 Y L2. MALFORMACIÓN DE VASOS ESPINALES POR EL PROCESO INFLAMATORIO DE LA FRACTURA.
COMPRESIÓN RADICULAR, ADHERENCIAS EXTRADURALES.

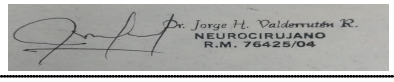
Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ES184	RUBEN DARIO PRADO GRANDA	ANESTESIOLOGO
ES219	JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO	ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

MG267	JULIAN DAVID PELAEZ ARCILA	AYUDANTE



JORGE HERNAN VALDERRUTEN ROMERO
Reg. 76425
NEUROCIRUGIA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***